

TEMA 7.9 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Trastornos del Ánimo: Trastorno Bipolar

PERFIL EUNACOM 1.12.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Trastorno Bipolar (TAB)** es una patología del ánimo crónica y recurrente, de base genética, que se caracteriza por la alternancia de episodios de manía, hipomanía o mixtos, con episodios de **Depresión**. Es una de las condiciones más preguntadas en el EUNACOM debido al alto riesgo de error diagnóstico y a la contraindicación absoluta de ciertos fármacos comunes.

Etiología y Epidemiología

El trastorno bipolar tiene un componente genético muy marcado, sugiriéndose una herencia de tipo **autosómica dominante**. Es fundamental indagar en los antecedentes familiares (padres, hermanos). - **Edad de debut**: Típicamente joven, alrededor de los **18 años** (adolescencia tardía o inicios de los 20), a diferencia de las depresiones reactivas que pueden aparecer a cualquier edad. - **Curso clínico**: Aunque el diagnóstico se basa en la manía, el paciente suele pasar mucho más tiempo en episodios depresivos.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: Se cree que existe una disregulación en los sistemas de neurotransmisión (dopamina, serotonina y noradrenalina) y en los mecanismos de estabilidad de la membrana neuronal, lo que explica la respuesta a los "estabilizadores del ánimo".

Diagnóstico Clínico

El diagnóstico es **estrictamente clínico**. Se requiere la presencia de al menos un episodio de exaltación del ánimo (maniaco, hipomaniaco o mixto) en la vida del paciente.

1. Episodio Maniaco

Debe durar al menos **4 días** y presentar: - **Ánimo expansivo o irritable**: El paciente está "lleno de energía" o se enoja con extrema facilidad. - **Verborrea y Fuga de ideas**: Habla aceleradamente, interrumpe y salta de un tema a otro dejando ideas inconclusas. - **Disminución de la necesidad de sueño**: A diferencia del insomnio (donde el paciente sufre por no dormir), aquí el paciente se siente descansado y con energía tras dormir pocas horas. - **Conductas de riesgo**: Gastos excesivos, hipersexualidad sin protección, negocios impulsivos o deportes extremos. - **Psicosis**: Puede haber delirios de **grandeza (megalomanía)** o, muy frecuentemente, **paranoia** (creer que hay un complot en su contra). - **Agitación psicomotora**: Riesgo de agresión hacia terceros o al médico.

2. Episodio Hipomaniaco

Es similar a la manía pero de **menor intensidad**: - No presenta psicosis. - No requiere hospitalización. - No genera una disfunción social o laboral tan grave. - Menor grado de distraibilidad y agitación.

3. Episodio Mixto

Presencia simultánea de síntomas maniacos (irritabilidad, verborrea) y depresivos (tristeza profunda, anhedonia). Suele tener un alto riesgo suicida.

Manejo Farmacológico

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA: Los **antidepresivos** (ISRS, tricíclicos, etc.) están contraindicados en el trastorno bipolar, ya que pueden inducir un "viraje" (switch) a manía o favorecer el ciclo rápido.

El tratamiento se basa en los **estabilizadores del ánimo**, que deben mantenerse a **permanencia** para prevenir recaídas.

- **Litio (Carbonato de Litio)**: Es el estándar de oro. Muy efectivo pero con rango terapéutico estrecho.
- **Anticonvulsivantes**:
 - - **Ácido Valproico**: De elección en episodios mixtos y cicladores rápidos.
 - - **Carbamazepina**.
 - - **Lamotrigina**: Útil especialmente para la prevención de la fase depresiva.
- **Antipsicóticos (en agudo)**:
 - - **Haloperidol**: Se usa para la **agitación psicomotora**. Dosis: **5 mg IM**.
 - - **Quetiapina u Olanzapina**: Tienen efectos estabilizadores adicionales.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: No confundas la dosis de Haloperidol. En el **Delirium** del adulto mayor se usan dosis bajas (0.5 mg), pero en la **agitación del paciente bipolar o psicótico** se usan dosis plenas (5 mg IM).

Toxicidad por Litio

El litio es un fármaco de manejo delicado que requiere niveles plasmáticos (**litemia**) periódicos.

- **Contraindicaciones**: **Insuficiencia Renal** (el litio se excreta 100% por vía renal) y embarazo (es teratogénico).
- **Clínica de Intoxicación**:
 - - **Gastrointestinal**: Vómitos, dolor abdominal.
 - - **Neurológico**: Temblor grueso, ataxia (camina como ebrio), confusión.
 - - **Renal**: Poliuria por diabetes insípida nefrogénica.
- **Manejo**:
 - 1. Solicitar Litemia.
 - 2. **Hidratación con Suero Fisiológico** (es la medida inicial más importante).
 - 3. Hemodiálisis de urgencia en casos graves o niveles muy altos.

Situaciones Especiales

Embarazo

El litio es teratogénico. Si una paciente planea embarazarse: - Debe estar muy estable antes de intentar suspender el fármaco bajo supervisión estricta. - Si el episodio es grave y no se pueden usar fármacos, la **Terapia Electroconvulsiva (TEC)** es una opción segura y eficaz.

Terapia Electroconvulsiva (TEC)

Aunque estigmatizada, es una herramienta de alta eficacia en: - Depresiones con alto riesgo suicida inminente. - Manía refractaria o muy severa. - Trastorno bipolar durante el embarazo. - **Esquizofrenia** catatónica o descompensada que no responde a fármacos.

TABLA 7.9.1: CARACTERÍSTICA VS MANÍA

CARACTERÍSTICA	MANÍA	HIPOMANÍA
Duración mínima	4 días	4 días
Intensidad	Grave, interfiere con la vida	Leve a moderada
Psicosis	Puede estar presente	Ausente
Hospitalización	Frecuente	No requiere

Cicladores Rápidos

Se define como el paciente que presenta **4 o más episodios** de alteración del ánimo en un año (o cambios muy frecuentes en menos de un mes). - **Tratamiento de elección:** Anticonvulsivantes (especialmente Ácido Valproico), ya que el litio suele ser menos efectivo en estos casos.

Tips para el Examen: Identificación de Casos

- **Paciente joven agresivo/verborreico:** Sospechar Manía. El primer paso es contención (Haloperidol 5mg IM). - **Paciente con "personalidad difícil" que se irrita en la consulta:** Puede ser un cuadro maniaco en evolución. Mantener siempre la salida del consultorio accesible para el médico. - **Paciente deprimido con antecedentes de "gastos excesivos" o "mucha energía" en el pasado:** Es un TAB. **No dar antidepresivos**, dar estabilizadores del ánimo. - **Paciente en tratamiento con litio que llega con temblor y vómitos:** Pensar siempre en intoxicación por litio e hidratar.

NOTA CLÍNICA

El trastorno bipolar bien tratado permite una vida funcional y normal. El error más grave es tratarlo como una depresión unipolar, lo que daña el patrimonio y la estabilidad del paciente.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 22 años es traído por su familia porque lleva 5 días hablando sin parar, con ideas que cambian rápidamente, dice que va a montar una empresa millonaria, durmió solo 2 horas anoche sin sentirse cansado y ayer gastó todos sus ahorros en criptomonedas. Está irritable y agresivo al ser evaluado. ¿Cuál es la conducta inmediata y el tratamiento de fondo?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos del Ánimo: Trastorno Bipolar. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Todos los antidepresivos están absolutamente contraindicados en el trastorno bipolar; pueden virar una depresión a manía.
- El episodio maniaco requiere mínimo 4 días; incluye ánimo elevado/irritable, verborrea, fuga de ideas, disminución de sueño y conductas de riesgo.
- Agitación psicomotora en trastorno bipolar o psicosis: haloperidol (aldol) 5 mg IM.
- Litio: primera línea en trastorno bipolar; contraindicado en insuficiencia renal y embarazo (teratogénico).
- Intoxicación por litio: vómitos, temblor, ataxia, poliuria; manejo con suero fisiológico y hemodiálisis si grave.
- Episodios mixtos y cicladores rápidos: se manejan con anticonvulsivantes, no con litio.
- El trastorno bipolar suele debutar entre los 18 y 30 años; la depresión muy grave o psicótica en jóvenes obliga a sospecharlo.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS DEL ÁNIMO: TRASTORNO BIPOLAR)**PREGUNTA 1**

Hombre de 22 años es traído por su familia porque lleva 5 días hablando sin parar, con ideas que cambian rápidamente, dice que va a montar una empresa millonaria, durmió solo 2 horas anoche sin sentirse cansado y ayer gastó todos sus ahorros en criptomonedas. Está irritable y agresivo al ser evaluado. ¿Cuál es la conducta inmediata y el tratamiento de fondo?

- A)** ISRS por sospecha de episodio hipomaniaco en depresión bipolar
- B)** Haloperidol 5 mg IM para la agitación; luego estabilizador del ánimo (litio o anticonvulsivante) a permanencia
- C)** Benzodiazepinas para el insomnio y observación
- D)** Diagnóstico de TDA en adulto; metilfenidato
- E)** Observación y psicoterapia; no requiere fármacos en el primer episodio

PREGUNTA 2

Mujer de 30 años con trastorno bipolar conocido y bien controlada con litio queda embarazada. Está asintomática actualmente. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto al litio?

- A)** Mantener el litio durante todo el embarazo sin cambios
- B)** Suspender el litio abruptamente y no administrar ningún fármaco
- C)** Evaluar con psiquiatría: si está bien controlada considerar discontinuar con seguimiento estrecho; si riesgo alto mantener o usar electroconvulsoterapia
- D)** Cambiar a antidepresivo ISRS que es seguro en el embarazo
- E)** Iniciar anticonvulsivante (ácido valproico) como alternativa más segura

PREGUNTA 3

Paciente de 35 años consulta por depresión severa. Revisando su historia, se documenta que hace 8 meses durmió solo 3 horas diarias por 2 semanas, gastó todo su sueldo y fue muy activo sexualmente con múltiples parejas, período que él describe como "de mucha energía". ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

- A)** Depresión mayor reactiva; iniciar ISRS
- B)** Trastorno bipolar con depresión actual; estabilizador del ánimo (litio o anticonvulsivante)
- C)** Trastorno de personalidad límite; psicoterapia
- D)** TDA en adulto; metilfenidato
- E)** Esquizofrenia; antipsicótico atípico

RESUMEN: TRASTORNOS DEL ÁNIMO: TRASTORNO BIPOLAR

El trastorno bipolar es una enfermedad genética (herencia autosómica dominante) con alta prevalencia de antecedentes familiares, que debuta típicamente entre los 18 y 30 años. Se diagnostica cuando existe al menos un episodio maniaco, hipomaniaco o mixto. La principal relevancia clínica para el EUNACOM es que los antidepresivos están absolutamente contraindicados: pueden virar una depresión bipolar a manía. La clínica maniaca requiere mínimo 4 días de duración e incluye: ánimo elevado o irritable, verborrea con fuga de ideas, hiperactividad, disminución de la necesidad de sueño (sin angustia), y conductas de riesgo (gastos impulsivos, sexo sin protección, deportes extremos). En casos graves puede haber psicosis (delirios paranoides o megalomaniacos) y agitación psicomotora. El tratamiento del trastorno bipolar usa estabilizadores del ánimo a permanencia: litio (carbonato de litio, de elección) y anticonvulsivantes (ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina). La agitación aguda se maneja con haloperidol 5 mg IM. La elección del estabilizador del ánimo es: litio como primera línea; anticonvulsivantes en episodios mixtos, cicladores rápidos, intolerancia al litio o insuficiencia renal. La intoxicación por litio se caracteriza por vómitos, dolor abdominal, temblor, ataxia y poliuria (diabetes insípida nefrogénica); el manejo es hidratación con suero fisiológico y hemodiálisis si es grave. El litio es teratogénico y está contraindicado en el embarazo (opciones: discontinuar con seguimiento estrecho, mantener si el riesgo es alto, o electroconvulsoterapia). La electroconvulsoterapia tiene indicaciones específicas: depresión severa refractaria con riesgo suicida, trastorno bipolar grave en el embarazo y esquizofrenia muy descompensada refractaria.